

Fecha Última Actualización: 16-08-2023 22:39:29

Página 1 de 2

Información Paciente

Nombre : Mauricio Rosamel Valdivia Cisternas
Edad : 54a 10m 12d
Dirección : San Pedro 485

Rut : 11.266.112-3
Fecha Nacto: 04/10/1968
Comuna : La Florida

N° Archivo : 0111708
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 4024 5551

N° Epicrisis
366318

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Cirugía Sector B - Mediana Compleji
Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 11/08/2023 13:47
Fecha Egreso : 16/08/2023 22:08

Días Estadía : 5

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

shock séptico

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

INGRESO UCI
Módulo E. Cama 1

ANTECEDENTES:

- Médicos: DHC terminal por OH trasplantado en enero 2023
- Quirúrgicos: trasplante hepático enero 2023
- Fármacos: Tacrolimus 3 mg cada 12 h. Aciclovir 400 mg cada 12 h. Cotrimoxazol Forte L-M-V, Prednisona 20 mg/día. Elcal D. Furosemida 20 mg/día. Espironolactona 50 mg/día.
- Alergias: no reportadas
- Hábitos: Tabaco (-), OH suspendido en enero 2022, Drogas (-)

ENFERMEDAD ACTUAL:

Paciente con antecedente de DHC terminal por OH que fue trasplantado el 14/01/2023. En control ambulatorio con equipo de hepatobiliar, mala adherencia a tratamiento y evidencian nueva alteración de perfil hepático por lo que ingresa de manera electiva a hospitalización en sector de cirugía B con los diagnósticos de:

- THO enero 2023.
- Estenosis vía biliar. ERCP agosto 2023 con instalación de 2 prótesis.
- Biopsia: rechazo severo agosto 2023.
- Mala adherencia a tratamiento.

Realizan TC de abdomen y pelvis (13.08.23) que reporta cambios postquirúrgicos de trasplante hepático. El injerto presenta cambios dismórficos, concordantes con antecedente clínico de rechazo. Adecuada permeabilidad estructuras vasculares del injerto. Acentuada ascitis de distribución difusa y esplenomegalia como marcadores de hipertensión portal. Prótesis biliar in situ.

Evoluciona tórpidamente, con shock séptico foco abdominal y bacteriemia por *Klebsiella pneumoniae* BLEE tipo NDM, con falla multiorgánica que requiere IOT + VMI, apoyo con TRR, NAD a dosis crecientes, por lo que solicitan cama en UCI donde ingresa para continuar manejo.

En UPC evoluciona con shock profundo y falla orgánica múltiple con comp hemodinámico, renal, hepático y coagulopatía. Se conecta a SLED + ceftazidima/avibactam + aztreonam. Por evolución tórpida a pesar de DVA en dosis máxima finalmente se

Fecha Epicrisis : 16/08/2023 22:39

Página 1 de 2

Fecha Última Actualización: 16-08-2023 22:39:29

Página 2 de 2

desestima posibilidad de re enlistar para trasplante y se prioriza apoyo de fin de vida. Paciente fallece 16/08/23 a las 22:08.

Diagnóstico de Egreso

FALLA Y RECHAZO DE TRASPLANTE DE HÍGADO -
Shock séptico - abdominal + bacteremia por KPN BLE NDM

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Pcte fallece 16/08/23 a las 22:08

Plan Post Alta

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente


Maria Paz Cortez Farran
Médico Tratante (Staff)